

TEMA 3.53 • OBSTETRICIA

Lactancia Materna

Lactancia Materna

Fisiología

TABLA 3.53.1: HORMONA VS FUNCIÓN		
HORMONA	FUNCIÓN	ESTÍMULO
Prolactina	Producción de leche	Caída de progesterona postparto
Oxitocina	Eyección de leche	Succión del recién nacido

NOTA CLÍNICA

Dopamina inhibe la prolactina → antidopaminérgicos (antipsicóticos) pueden causar galactorrea incluso en no embarazadas.

Para suspender la lactancia: Cabergolina o bromocriptina (agonistas dopaminérgicos).

Calostro

- Primeros 3–5 días post-parto
- Rico en IgA y células inmunológicas
- Rol inmunológico superior al de la leche madura

Beneficios de la Lactancia Materna

Para la madre

- Disminuye riesgo de **cáncer de mama** - Ayuda a bajar de peso - Favorece el apego con el recién nacido - Es económica

Para el recién nacido

- Disminuye la **gravedad** de infecciones respiratorias y entéricas (factor de hospitalización) - Excelente desde el punto de vista nutricional - Disminuye el riesgo de **muerte súbita del lactante** - Disminuye el riesgo de alergias (proteína de leche de vaca, etc.)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La leche materna **no tiene suficiente hierro** para cubrir las necesidades del lactante. Se recomienda **suplementar con hierro desde los 4 meses** en niños con lactancia exclusiva.

Contraindicaciones de la Lactancia Materna

Contraindicaciones Absolutas y Permanentes

TABLA 3.53.2: CONDICIÓN VS DETALLE	
CONDICIÓN	DETALLE
Infección por VIH	Principal contraindicación
HTLV-1 y HTLV-2	Virus de leucemia T humana
Galactosemia	Enfermedad metabólica genética grave — la leche es letal
Drogas de abuso	Cocaína, heroína, etc.

Contraindicaciones Absolutas pero Transitorias

TABLA 3.53.3: CONDICIÓN VS DETALLES	
CONDICIÓN	DETALLES
Tuberculosis activa	Contraindica hasta completar tratamiento materno; luego puede reiniciarse
VHS con lesiones en mama	Contraindica mientras haya lesiones activas en la mama (si lesiones son bucales del niño, mantener con precauciones)

Fármacos que Contraindican la Lactancia

TABLA 3.53.4: FÁRMACO VS RAZÓN	
FÁRMACO	RAZÓN
Quimioterapia	Destruye células en división activa (el RN tiene proliferación celular intensa)
Metotrexato	Mismo mecanismo

Lo que NO contraindica la lactancia

TABLA 3.53.5: SITUACIÓN VS CONDUCTA	
SITUACIÓN	CONDUCTA
Hepatitis B materna	Vacunar al RN + inmunoglobulina anti-HB hiperinmune → lactancia SÍ
Hepatitis C materna	No hay casos documentados de transmisión por leche → lactancia SÍ
Diarrea del RN	Lactancia materna con mayor razón (previene deshidratación)
Vómitos del RN	Lactancia materna (previene deshidratación)
COVID-19 materno	Usar mascarilla N95 durante la alimentación → lactancia SÍ
Mastitis materna	Lactancia SÍ (vaciamiento es parte del tratamiento)

| **Psicosis puerperal** | No contraindica la leche en sí, pero puede contraindicar el *proceso de amamantamiento* si hay riesgo para el RN |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Lactancia Materna, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lactancia Materna. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Fisiología
- Calostro
- Beneficios de la Lactancia Materna
- Para la madre
- Para el recién nacido
- Contraindicaciones de la Lactancia Materna
- Contraindicaciones Absolutas y Permanentes

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LACTANCIA MATERNA)**PREGUNTA 1**

Respecto a Lactancia Materna, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Lactancia Materna se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Lactancia Materna debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Lactancia Materna requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Lactancia Materna es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Lactancia Materna no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Lactancia Materna?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Lactancia Materna. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: LACTANCIA MATERNA

:::note Dopamina inhibe la prolactina → antidopaminérgicos (antipsicóticos) pueden causar galactorrea incluso en no embarazadas.

:::warning La leche materna no tiene suficiente hierro para cubrir las necesidades del lactante. Se recomienda suplementar con hierro desde los 4 meses en niños con lactancia exclusiva. :::